

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Fluocinolone acetonide 0.59mg (레티서트이식정, 바슈롬싸우스아시아링크)

- ☐ 제형, 성분·함량 :
 - 1정 중 Fluocinolone acetonide 0.59mg
- ☐ 효능 효과 :
 - 안구 후방의 만성 비감염성 포도막염의 치료
- ☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일
2011년 제1차 약제급여평가위원회 : 2011년 1월 20일
 - 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2010년 11월 29일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “안구 후방의 만성 비감염성 포도막염의 치료”에 허가받은 약제로 전신표준 요법과 직접비교시 포도막염 재발률 및 재발횟수 등에서는 개선을 보였으나, 재발시기에 대한 효과가 불분명하며, 시력 관련 지표에서 유의한 차이가 없고 눈 관련 이상반응 발생이 유의하게 많았으며, 제외국 평가결과 등을 고려시, 대체약제와의 상대적 임상적 유용성이 불분명하므로 비급여 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “안구 후방의 만성 비감염성 포도막염의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 포도막염에 허가받은 prednisolone, methylprednisolone acetate, triamcinolone acetonide, cyclosporine 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 국소 스테로이드 제제로서, 안구의 후방에 이식하여 약 30개월간 약물을 방출하도록 설계된 지속형 방출제제임¹⁾.
- 신청품은 교과서에서 만성 비감염성 포도막염에서 염증을 조절하는데 효과적으로 보이며 전신적 약물요법의 양을 감소시킬수 있으나, 부작용으로 백내장 및 녹내장이 발생하는 것으로 언급되어있음²⁾³⁾.
- 최근 1년 이상 재발성 또는 나빠지는 비감염성 후방 포도막염 환자 146명을 대상으로 한 3년간의 다기관, 무작위, 공개, 대조 2b/3상 임상시험에서 신청품군(n=66)과 스테로이드 단독 또는 스테로이드와 면역억제제의 병용요법인 표준(전신)요법(n=74)의 안전성 유효성을 비교한 결과, 일차평가변수인 첫 재발시기(신청품군은 12주 이후)에서 신청품과 표준요법군은 유의한 차이가 없었으나, 염증의 증거가 없는 재발 추정 환자를 제외(censoring)한 생존분석에서는 유의한 개선을 나타냈음($p<0.01$)⁴⁾.
 - 2년간 적어도 1회이상 재발한 환자의 비율은 신청품군 34.8%, 표준치료군 64.9%로 신청품군에서 유의하게 낮았으며($p<0.01$), 재발 횟수의 중앙값은 신청품군 0.3 표준치료군 1.2이었음($p\leq 0.01$).
 - 시험 종료시 신청품군과 표준치료군의 각 71.2%와 73.0%에서 시력이 안정되었으며, 신청품군의 17.2%와 표준치료군의 14.3%에서 시력이 개선되었으나, 통계적으로 유의한 차이는 없었음($p=0.66$).

- 눈에 대한 치료관련 이상반응은 신청품군 95.5%, 표준치료군 39.2%였으며, 눈 이외의 이상반응 발생은 신청품군 60.6%, 표준치료군 67.6%였음.
- 과거 포도막염에 대한 치료를 받은 경험이 있고 최근 1년 이상 재발성 비감염성 후방포도막염 환자 278명(0.59mg 110명, 2.1mg 168명)을 대상으로 한 3년간의 다기관, 무작위, 이력 대조(historically controlled) 시험에서 fluocinolone acetonide 이식정의 안전성 유효성을 평가한 결과, 신청품 투여군에서 재발률이 이식전 62%(1년)에서 이식후 4%(1년), 10%(2년), 20%(3년)으로 감소하였으며, 이식하지 않은 안구에 비해 이식한 안구가 더 많이 시력이 통계적으로 유의하게 개선되었음($p<0.01$)⁵⁾.
- 학회에서는 국내에는 아직 보고된 논문이 없고 국제적으로 발표된 논문도 제한적이며, 표준치료에 비하여 우수하다고 볼 수 없으므로, 더 많은 임상적 연구가 필요하다는 의견임⁶⁾.
- EMEA⁷⁾에서는 신청품이 표준치료에 비해 우수한지가 명확하지 않으며, 신청품의 눈 관련 부작용의 위험이 전신 면역치료와 관련된 전신적 부작용에 비해 낮다는 근거가 제시되지 않아 risk- benefit balance가 부정적이라는 사유로 허가 철회되었음⁸⁾⁹⁾.

○ 비용 효과성

- 포도막염에 허가되거나 급여기준상 사용가능한 약제로 prednisolone(경구), methylprednisolone acetate, triamcinolone acetonide, cyclosporine, mycophenolate mofetil을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품의 연간 소요비용은 ■■■■■원이고, 대체약제의 연간 소요비용은 ■■■■■원 임.

○ 재정 영향¹⁰⁾

- 제약사 제출 예상사용량¹¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹²⁾은 1차~5차년도에 연간 약 ■■■■■원으로 예상됨.
 - 다만, 기존에 받고 있던 대체약제의 비용 또는 신청품의 병용약제 등에 따라 재정 영향은 달라질 수 있으며, 허가사항인 ‘안구 후방의 만성 비감염성 포도막염 치료’에 사용시 대상환자수 및 절대재정소요금액은 더 증가할 수 있을 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국에 등재되어 있음.
- 신청가는 대체약제와의 상대비율 적용가격보다 고가에 해당됨¹³⁾.

Reference

- 1) Martindale 2009 elec ver.
- 2) Yanoff & Duker: Ophthalmology, 3rd ed.
- 3) Firestein: Kelley's Textbook of Rheumatology, 8th ed.
- 4) Pavesio C. et al, Evaluation of an intravitreal fluocinolone acetonide implant versus standard systemic therapy in noninfectious posterior uveitis. Ophthalmology. 2010 Mar;117(3):567-75, 575.e1. Epub 2010 Jan 15.
- 5) Callanan DG, et al, Treatment of posterior uveitis with a fluocinolone acetonide implant: three-year clinical trial results. Arch Ophthalmol. 2008 Sep;126(9):1191-201
- 6) 대한안과학회
- 7) EMEA: European Medicines Agency
- 8) EMEA Questions and Answers on the Withdrawal of the marketing application (2007.8.16)
- 9) EMEA Withdrawal Assessment Report (2007.10.18)
- 10) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 11) 제약사에서는 ‘중증 비염증성 후방 포도막염 환자 중, 장기간 치료후 마지막으로 신청품을 선택하는 녹내장 선행치료를 시행한 환자’ 로 추정한 예상사용량을 제시하였음.
- 12) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청품 소요비용
- 13) 미국 약가 비율 참조 (적용 환율: 2010년 7월 평균 최종고시 매매기준율)